CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Adherencia a Guía de Práctica Clínica – Diabetes Mellitus tipo 2

Parámetro 1. Evaluación y registro de condición controlada

Pregunta de evaluación: ¿Se documentó de forma adecuada en la historia clínica la evaluación del control de la Diabetes Mellitus tipo 2, teniendo en cuenta el registro del valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c), la fecha del examen, la interpretación clínica del resultado y la determinación de si el paciente se encuentra o no dentro de metas de control?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica: En la nota clínica debe evidenciarse la evaluación del control metabólico del paciente mediante el registro del valor de HbA1c más reciente, incluyendo la fecha del examen y su interpretación clínica. El profesional debe indicar si el resultado corresponde o no a un adecuado control glucémico según las metas individualizadas

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Se registra el valor de HbA1c con su fecha correspondiente y se realiza una interpretación clínica clara del resultado, indicando si el paciente se encuentra o no dentro de metas de control metabólico. La información consignada permite evidenciar una evaluación completa del control de la diabetes.

4 – Cumple adecuadamente: Se registra el valor de HbA1c en la historia clínica; sin embargo, no se documenta claramente la interpretación clínica del resultado o no se especifica explícitamente si el paciente se encuentra o no controlado.

1 – No cumple: No se registra HbA1c reciente, no se documenta evaluación del control metabólico o no existe información que permita determinar si se valoró el control de la diabetes.

Parámetro 2. Evaluación del riesgo cardiovascular

Pregunta de evaluación: ¿Se registra en la historia clínica la estratificación del riesgo cardiovascular del paciente con diabetes mellitus tipo 2, teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados y la clasificación del riesgo según las recomendaciones actualizadas?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica: La historia clínica debe incluir la valoración del riesgo cardiovascular según CONSENSO COLOMBIANO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIAS EN ADULTOS 2024.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Se documenta explícitamente la estratificación del riesgo cardiovascular del paciente.

4 – Cumple adecuadamente: Se mencionan factores de riesgo cardiovascular o comorbilidades asociadas; sin embargo, no se registra de forma explícita la clasificación o estratificación final del riesgo cardiovascular.

Se menciona otra escala de estratificación del riesgo cardiovascular del paciente.

1 – No cumple: No se evidencia evaluación del riesgo cardiovascular en la historia clínica.

Parámetro 3. Evaluación de nefropatía diabética

Pregunta de evaluación: ¿Se documenta en la historia clínica la evaluación de compromiso renal asociado a diabetes mellitus tipo 2, incluyendo la solicitud o registro de exámenes pertinentes (como creatinina sérica, tasa de filtración glomerular estimada o albuminuria), la interpretación de los resultados y la conducta clínica correspondiente según los hallazgos?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica: Debe evidenciarse la valoración del estado renal del paciente mediante el registro o solicitud de exámenes como creatinina sérica, tasa de filtración glomerular estimada (TFG) y albuminuria o microalbuminuria. Además, el profesional debe realizar la interpretación clínica de los resultados y establecer la conducta correspondiente, como seguimiento, control periódico o inicio de medidas terapéuticas para protección renal.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Se documenta la evaluación renal completa, incluyendo registro o solicitud de exámenes pertinentes, interpretación clínica de los resultados y definición de la conducta médica correspondiente según los hallazgos.

4 – Cumple adecuadamente: Se registra la solicitud o el resultado de los exámenes renales; sin embargo, no se documenta claramente la interpretación clínica de los resultados o la conducta a seguir.

1 – No cumple: No se evidencia evaluación renal ni solicitud de exámenes relacionados con el tamizaje o seguimiento de nefropatía diabética.

Parámetro 4. Elección de tratamiento

Pregunta de evaluación: ¿Se establece en la historia clínica un tratamiento hipoglucemiante acorde con las recomendaciones actualizadas para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, considerando las características clínicas del paciente y sus comorbilidades?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica: Debe consignarse el tratamiento farmacológico indicado para el control de la diabetes, especificando el medicamento, dosis y esquema terapéutico. Idealmente, la elección del tratamiento debe estar relacionada con el perfil clínico del paciente, su control metabólico y la presencia de comorbilidades, como enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o riesgo de hipoglucemia.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Se documenta un tratamiento farmacológico adecuado según las recomendaciones vigentes, con registro claro del medicamento, dosis y justificación clínica acorde con las características del paciente.

4 – Cumple adecuadamente: Se registra el tratamiento farmacológico para la diabetes; sin embargo, no se documenta la justificación clínica o no se evidencia claramente la relación con las recomendaciones actualizadas.

1 – No cumple: No se documenta tratamiento farmacológico o el manejo registrado no es acorde con las recomendaciones clínicas para el manejo de la diabetes. Se identifica una formulación farmacológica que incluye medicamentos con interacción potencialmente no recomendada, lo cual representa un riesgo para la seguridad del paciente y requiere ajuste del tratamiento.

Parámetro 5. Establecimiento de metas de control

Pregunta de evaluación: ¿Se registran en la historia clínica las metas de control del paciente con diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo con las recomendaciones actualizadas de la Guía de Práctica Clínica?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica: El profesional debe documentar las metas de control clínico del paciente, las cuales pueden incluir metas de hemoglobina glicosilada (HbA1c), presión arterial, perfil lipídico u otros parámetros relevantes. Estas metas deben orientarse al seguimiento del tratamiento y al control integral del riesgo cardiovascular del paciente.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Se registran metas específicas de control para el paciente, claramente definidas y coherentes con las recomendaciones de la GPC.

4 – Cumple adecuadamente: Se mencionan metas de control de forma general o implícita, pero no se especifican valores o parámetros concretos.

1 – No cumple: No se documentan metas de control para el manejo de la diabetes.

Parámetro 6. Recomendaciones de cambios en el estilo de vida

Pregunta de evaluación: ¿Se registran en la historia clínica intervenciones relacionadas con cambios en el estilo de vida del paciente con diabetes mellitus tipo 2, incluyendo recomendaciones sobre control de peso, alimentación saludable, reducción en el consumo de sal, aumento de la actividad física y disminución o suspensión del consumo de alcohol y tabaco?

Descripción de lo que debe registrarse en la historia clínica: La historia clínica debe incluir recomendaciones relacionadas con el manejo no farmacológico de la diabetes, tales como orientación nutricional, incremento de la actividad física, control del peso corporal, reducción del consumo de sal, y recomendaciones para disminuir o suspender el consumo de alcohol y tabaco. Estas intervenciones hacen parte del manejo integral del paciente con diabetes.

Criterios de calificación

5 – Sí cumple: Se registran recomendaciones específicas y claras relacionadas con cambios en el estilo de vida, evidenciando intervención educativa o consejería dirigida al paciente.

4 – Cumple adecuadamente: Se registran recomendaciones generales sobre estilo de vida saludable, pero sin intervenciones individualizadas

1 – No cumple: No se evidencian recomendaciones relacionadas con cambios en el estilo de vida en la historia clínica.

La metodología de evaluación propuesta fue revisada y validada por la Subgerencia Científica, el área de Calidad, el servicio de Medicina Familiar y el área de Academia e Investigación. Durante dicha revisión se consideró que la herramienta presenta preguntas claras y pertinentes para evaluar la GPC de diabetes mellitus tipo 2 conforme a las recomendaciones trazadoras.